認定結果(テスト用設定)

テスト用架空事例

要介護度	要介護1
認定日	令和8年9月14日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年8月3日～令和9年2月28日(新規・6か月)(テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年8月20日 (テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	新規申請		
対象者氏名	森田 静江 (もりた しずえ)	性別	女
生年月日	昭和21年(1946年)1月20日	年齢	80歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

なし(今回が初めての申請。認定後に通所介護の利用を予定)。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	夫(83歳)と二人暮らし。夫は高血圧で通院中だが、身の回りのことは自分でできる。長女(52歳)は市内に住み、月2回ほど訪問。
居住環境	築35年の木造2階建て持ち家。生活は1階のみ。玄関に段差(約20cm)、浴室に手すりあり。
使用している機器等	なし。
生活歴	地元の生まれ。結婚後は主婦として家事と子育てを担い、料理が得意だった。60代までは公民館の料理教室で教えていた。
本人・家族の主訴	本人:「物忘れは年のせい。まだ家のことは自分でできる。」 夫:「薬を飲んだか何度も聞かれる。火の消し忘れが心配で、自分もいつまで見ていられるか不安。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	(ない) 左上肢　右上肢　左下肢　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	(ない) 肩関節　股関節　膝関節　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-4 起き上がり	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-5 座位保持	(できる) 自分の手で支えればできる　支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	(支えなしでできる) 何か支えがあればできる　できない
1-7 歩行	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-8 立ち上がり	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-9 片足での立位	支えなしでできる (何か支えがあればできる) できない
1-10 洗身	(介助されていない) 一部介助　全介助　行っていない
1-11 つめ切り	(介助されていない) 一部介助　全介助
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない)) 約1m離れた視力確認表の図が見える 目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない 見えているのか判断不能
1-13 聴力	(普通) 普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-2 移動	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-3 えん下	(できる) 見守り等　できない
2-4 食事摂取	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-5 排尿	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-6 排便	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-7 口腔清潔	(介助されていない) 一部介助　全介助
2-8 洗顔	(介助されていない) 一部介助　全介助
2-9 整髪	(介助されていない) 一部介助　全介助
2-10 上衣の着脱	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-11 ズボン等の着脱	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-12 外出頻度	(週1回以上) 月1回以上　月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	(調査対象者が意思を他者に伝達できる) ときどき伝達できる ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	(できる) できない
3-3 生年月日や年齢を言う	(できる) できない
3-4 短期記憶	できる (できない)
3-5 自分の名前を言う	(できる) できない
3-6 今の季節を理解する	(できる) できない
3-7 場所の理解	(できる) できない
3-8 徘徊	(ない) ときどきある　ある

3-9 外出すると戻れない	(ない) ときどきある　ある　テスト用架空事例
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない) ときどきある　ある
4-2 作話	(ない) ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	(ない) ときどきある　ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない) ときどきある　ある
4-5 しつこく同じ話をする	ない (ときどきある) ある
4-6 大声をだす	(ない) ときどきある　ある
4-7 介護に抵抗する	(ない) ときどきある　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない) ときどきある　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない) ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない) ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない) ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	ない (ときどきある) ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない) ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない) ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない) ときどきある　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない (一部介助) 全介助
5-2 金銭の管理	介助されていない (一部介助) 全介助
5-3 日常の意思決定	できる(特別な場合でもできる) (特別な場合を除いてできる) 日常的に困難 できない
5-4 集団への不適応	(ない) ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない (見守り等) 一部介助　全介助
5-6 簡単な調理	介助されていない (見守り等) 一部介助　全介助

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)
□気管切開の処置　□疼痛の看護　□経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置
□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1 (J2) A1　A2　B1　B2　C1　C2
認知症高齢者の日常生活自立度	自立　Ⅰ (Ⅱa) Ⅱb　Ⅲa　Ⅲb　Ⅳ　M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-9 片足での立位は、壁に手をつけば保てる。 そのほかの起居動作・歩行は自分で行える。
第2群 生活機能	2-12 夫と近所のスーパーへ行くほか、長女の運転で月2回程度出かけている。一人で遠くへは出かけない。
第3群 認知機能	3-4 調査の直前に何をしていたか答えられなかった。生年月日・名前・季節は正しく答えた。 同じことを何度も聞き返す場面があった。
第4群 精神・行動障害	4-5 「薬は飲んだか」と、1日に何度も夫に同じことを聞く(週に数回)。 4-12 鍋を火にかけたまま忘れることが、この1か月で2回あった。
第5群 社会生活への適応	5-1 薬の飲み忘れや二重に飲むことがあり、夫が朝夕に一包化した薬を手渡している。 5-2 通帳と財布は夫が管理している。買い物の支払いは自分でするが、同じ物を何度も買ってくる。 5-5 夫が同行して見守っている。 5-6 調理は自分で行うが、火の消し忘れがあるため夫が見守っている。 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa。服薬・金銭の管理と火の始末に、夫の見守りと支援が欠かせない。
特別な医療	該当なし。

主治医意見書

テスト用架空事例

申請者	森田 静江 (女・80歳) 医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. アルツハイマー型認知症(初期)	令和7年10月頃
2. 高血圧症	約15年前
(2)症状としての安定性	安定
(3)経過及び治療内容	1年ほど前から物忘れが目立ち、令和7年10月にアルツハイマー型認知症と診断。HDS-R 19点。日常会話は保たれているが、近時記憶の障害があり、服薬や金銭の管理に支援を要する。 投薬:ドネペジル塩酸塩、降圧薬。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

なし

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):J2 認知症高齢者の日常生活自立度:Ⅱａ
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題あり/日常の意思決定:いくらか困難/意思の伝達:伝えられる
(3)認知症の行動・心理症状	なし(同じことを繰り返し聞くことがある)
(4)その他の精神・神経症状	なし
(5)身体の状態	利き腕:右/身長150cm・体重50kg/麻痺なし/関節の拘縮なし/褥瘡なし

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:自立/車いす:用いていない/歩行補助具:使用していない
(2)栄養・食生活	食事行為:自立/栄養状態:良好/留意点:減塩
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	認知症の進行、服薬の誤り、火の不始末 → 服薬の管理と見守り、通所介護による生活リズムの維持
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できる
(5)医学的管理の必要性	特になし
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	服薬:内服を確実に/その他:環境の変化に配慮
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

認知症高齢者の日常生活自立度はⅡａ。服薬・金銭管理に支援が必要で、高齢の夫一人の見守りでは限界がある。通所介護などの利用による支援が望ましい。